

ÚLCERA POR PRESIÓN II

María Inmaculada Vidales Flores, Carlos Agustín Quiñones López, Cristina Lorenzana González.

INTRODUCCIÓN

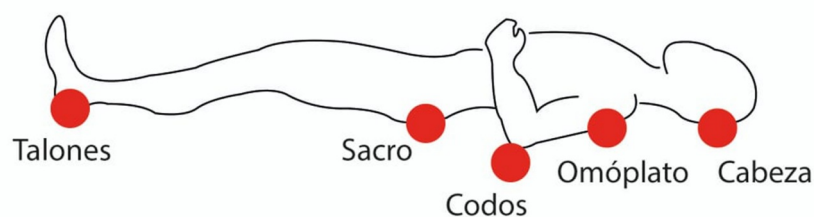
- **Definición** propuesta por la GNEAUPP (Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y heridas crónicas) es:
 - Una lesión localizada en la piel y/o tejido subyacente (habitualmente prominencia ósea) como resultado de la presión, o de la presión combinada con fuerzas de cizalla. También pueden aparecer sobre tejidos blandos, bajo la presión externa de materiales o dispositivos clínicos. Son un problema evitable en el 95% de los casos

Los factores de riesgo para su desarrollo son:

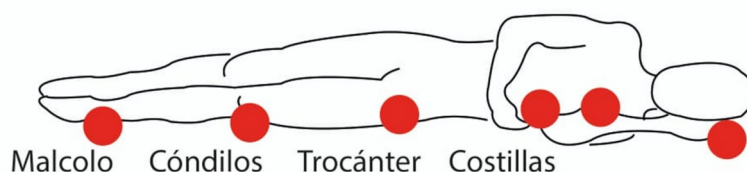
- **Intrínsecos:** edad y raza(más frecuente en caucásicos).
- **Extrínsecos:** presión, temperatura y humedad
- **Fisiopatológicos:** a consecuencia de diferentes problemas de salud.
- **Situacionales:** inmovilizaciones, arrugas en la ropa de cama.
- Derivados del tratamiento: tratamiento con inmunosupresores, vasopresores, sedantes, citostáticos, etc.

En cuanto a la localización estará relacionado con la zona sometida a presión o postura en la que se encuentre el paciente. El 90% se desarrollan en la parte inferior del cuerpo: el 40% en el sacro, el 20% talones, tuberosidades isquiáticas 15% y caderas 10%.

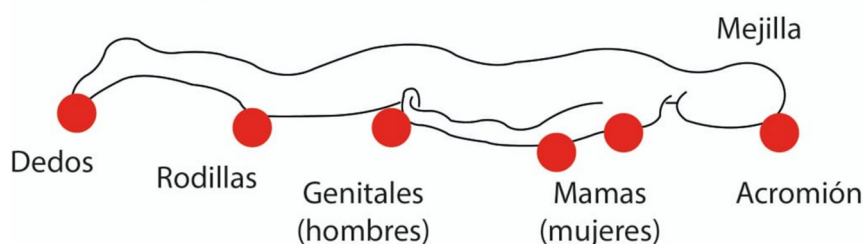
Decúbito dorsal



Decúbito lateral



Decúbito prono



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de una úlcera por presión es clínico y se pueden identificar en diferentes estadios o grados.

Tipos de úlceras por presión

- GRADO I: eritema que no palidece al eliminar la presión durante más de 30 segundos. Se presenta en piel intacta. Solo se ve afectada la epidermis.
- GRADO II: pérdida parcial de piel con abrasión. Produce dolor, se ve afectada la dermis y la epidermis.
- GRADO III: pérdida total del grosor de la piel con necrosis del tejido subcutáneo. A veces, no refieren dolor.
- GRADO IV: pérdida total con destrucción extensa, necrosis tisular, afectando a hueso, músculo y estructuras de sostén. Indolora.

VALORACIÓN

Escala de Norton Modificada

	4	3	2	1
Estado físico general				
	BUENO	MEDIANO	REGULAR	MUY MALO
Estado Mental				
	ALERTA	APÁTICO	CONFUSO	ESTUPOROSO
Actividad				
	AMBULANTE	CAMINA CON AYUDA	SENTADO	ENCAMADO
Movilidad				
	COMPLETA	LIMITADA LIGERAMENTE	MUY LIMITADA	INMÓVIL
Incontinencia				
	NINGUNA	OCASIONAL	URINARIA O FECAL	URINARIA Y FECAL

INTERPRETACIÓN

Tiene un rango total de 1 a 20 puntos. Puntuación total de 14 puntos o menos indica que el paciente es de riesgo y deberán adoptarse medidas preventivas. A menor puntuación el riesgo es mayor.

- Riesgo mínimo / sin riesgo: > de 14 puntos.
- Riesgo medio: 13 a 14 puntos.
- Riesgo alto: 10 a 12 puntos.
- Riesgo muy alto: 5 a 9 puntos.

EVALUACIÓN:

- En las primeras 24 horas del ingreso.
- Si el riesgo es muy alto se realizará cada 24 horas.
- Si el riesgo es moderado cada 3 días.
- Si el riesgo es bajo cada 7 días.

Escala EMINA

- Instrumento de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión en pacientes hospitalizados.
- Se valoran 5 parámetros: estado mental, movilidad, humedad por incontinencia, nutrición y actividad.
- Puntuación de 0-15 puntos. Riesgo alto de 15-8; medio 4-7; bajo 1-3; sin riesgo 0 puntos.

TRATAMIENTO

Prevención y cuidados generales: como nivel fundamental.

- No masajear prominencias óseas ni zonas enrojecidas.
- Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados.
- Manejo de la presión. Recordar que los colchones no sustituyen los cambios posturales. Los cambios posturales se realizarán cada 2 horas durante el día y cada 4 horas por la noche; si se encuentra en sedestación se realizarán cada 2 horas al igual que si el paciente está en estado de sedación.
- Está contraindicado el uso de rodete o flotador.
- Control nutricional.

Limpieza y cuidados locales: usaremos el esquema denominado TIME

- T: tejido desvitalizado: eliminación.
- Inflamación/infección: tratamiento.
- M: exudado(moisture en inglés), control con ambiente húmedo.
- E: bordes(edge), protegerlos.

Para la limpieza de las úlceras no deben emplearse antisépticos locales ya que afectan a la cicatrización, enlenteciéndola. En cambio, si se puede aplicar si vamos a realizar un desbridamiento cortante.

No están recomendados los productos que producen tinción ya que afectan a la valoración de la lesión.

Diferentes tipos de desbridamiento:

- **Desbridamiento cortante:** de primera elección por ser rápido y eficaz en tejido necrótico. Se realiza con bisturí, la técnica debe de ser estéril, se puede combinar con el desbridamiento enzimático o autolítico. Tiene inconveniente de sangrado (cuidado con coagulopatías) y posible introducción de bacterias en tejido sano si no se realiza con alta asepsia y antisepsia. Técnica dolorosa, se realiza en diferentes sesiones hasta llegar a tejido viable.
- **Desbridamiento quirúrgico:** la realiza el cirujano en quirófano con anestesia, se desbrida tejido necrótico y tejido sano circundante, recomendado en lesiones extensas, profundas y exudativas. Se realiza de urgencia por signos de sepsis o celulitis perilesional.
- **Desbridamiento enzimático:** mediante colagenasa. Usan enzimas exógenas de aplicación local, actúan degradando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina presente en las úlceras/heridas, se puede combinar con otros métodos. Se evitaren sustancias que puedan neutralizar las enzimas como algunos antisépticos yodados o los metales pesados.
- **Desbridamiento autolítico:** cura húmeda. Usan apósitos que proporcionan ambientes húmedos que facilitan autólisis, es el método menos traumático, es indoloro, selectivo y bien aceptado por los pacientes. Como inconveniente destaca la acción más lenta que otros métodos y puede macerar la piel sana perilesional.
- **Otros** menos usados como: bio-quirúrgico, osmótico, mecánico.
- **Toma de cultivo:**
 - Limpiar con suero fisiológico y aplicar antiséptico en los bordes.
 - Realizar desbridamiento.
 - Con hisopo: realizar movimiento rotatorio sin frotar fuerte en 10 puntos que abarquen en casi su totalidad la superficie de lecho de la úlcera.
 - Por aspiración percutánea: si hay mucho exudado se recoge entre 1-5 ml. Si no exuda:

- Lavar con suero fisiológico y secar.
- Elegir la zona con menor cantidad de esfacelos.
- Desinfectar piel.
- Punción con aguja intramuscular y jeringa de 10cc, en ángulo de 45º y con dirección oblicua al lecho de la herida a 0,5cm del borde de la herida.
- Realizar aspiración; si hay poco exudado se puede inyectar 0,5-1cc de suero fisiológico y se aspira.
- El contenido irá en un medio de transporte estéril para aerobios y anaerobios.

• Tratamiento de la úlcera

Considere el uso de antisépticos tópicos para las úlceras por presión que no avanzan hacia cicatrización y están críticamente colonizadas / infectadas localmente.

En general, no se recomiendan antibióticos tópicos para el tratamiento de las úlceras por presión.

Seleccione un apósito para las heridas en base a la:

- Capacidad para mantener el lecho de la herida húmedo
- Necesidad de abordar la carga bacteriana
- Naturaleza y el volumen de exudado de la herida
- Estado del tejido en el lecho de la úlcera
- Estado de la piel periulceral, valorar el uso de pomadas protectoras con Zinc

Material	Indicaciones / Contraindicaciones	Frecuencia
Hidrogel	• En úlceras secas, con poco exudado, con menos de 1/3 de tejido desvitalizado	• 24 horas a 72 horas
Hidrocoloide	• Úlceras con exudado leve-moderado • Úlceras infectadas, isquémicas	• 48 horas hasta 7 días máximo o hasta saturación. Se puede recortar. Vigilancia perilesional
Espumas	• Úlceras con exudado moderado o alto • Úlceras infectadas	• 48 horas hasta 7 días máximo o hasta saturación. Se puede recortar
Alginatos	• Úlceras con exudado alto. Se pueden usar si hay infección, no conjuntamente con colagenasa. En úlceras con tendencia al sangrado	• 48 horas hasta 7 días máximo o hasta saturación. Se puede recortar
Apositos con plata	• Úlceras infectadas	• Puede mantenerse hasta 7 días
Carbonactivado	• Mal olor de la úlcera • No recortar el apósito	• Cada 72 horas
Silicona	• Úlceras muy dolorosas o tumorales • No se puede usar si hay injertos con malla	• Se puede reutilizar según el producto utilizado.

BIBLIOGRAFÍA

- Moreno-Pina JP, Richart-Martínez M, Guirao-Goris JA, Duarte-Climents G. Análisis de las escalas de valoración del riesgo de desarrollar unas úlceras por presión. Enferm Clínica. 2007;17(4):186-97.

- Fuentelsaz Gallego C. Validación de la Escala EMINA: un instrumento de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión en pacientes hospitalizados. *Enferm Clínica* 2001;11(3):97-103.
- García Fernández FP, Montalvo Cabrerizo M, García Guerrero A, Pancorbo Hidalgo PL, García Pavón F, González Jiménez F et al. Guía de práctica clínica para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud; 2007.
- Piedrola de Angulo G, García JE, Gomez-Luis ML, Rodríguez FC, Torreblanca A. Procedimientos en Microbiología Clínica: recogida, transporte y conservación de las muestras. Ed Juan J, Picazo: Madrid; 1993.
- Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión (GNEAUPP). Directrices Generales de Prevención de las úlceras por presión. Castelldefels: GNEAUPP; 1996.
- Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP). Clasificación-Estadiaje de las Úlceras por Presión. Logroño: GNEAUPP; 2003.